

1. DATOS GENERALES:

NOMBRE: RAFAEL EDUARDO NUÑEZ MORALES	H.C: 1123731296
EDAD: 18 Años	FECHA DE NACIMIENTO: 21/09/2007
ESCOLARIDAD: Decimo grado.	FECHA DE EVALUACIÓN: 8/10/2025
DIRECCION: EL MOLINO	CORREO: madeley3138@gmail.com
EPS: Particular – Tía	EVALUADOR: Jainer Guzmán Vega
ACOMPAÑANTE: Madre	CELULAR: 3185505940

MOTIVO DE CONSULTA

Madre refiere, está teniendo dificultades académicas, perdió el año pasado.

ENFERMEDAD ACTUAL

Paciente con cuadro de evolución desde los 16 años cuando cursaba noveno grado caracterizada por dificultades en algunas materias, (trigonometría, física y química), con dolores en el cuerpo, dolores abdominales, somnolencia quedándose dormido en la institución educativa, sufre de mareos – se le va el cuerpo para un lado, deja las tareas para última hora, cuando le explican una temática logra comprender pero al momento de algunos exámenes no le va bien, no tiene habito de estudios, coloca música con tareas, para hacer tareas debe estar todo organizado, algunas dificultades en codificación, decodificación, evocación, pasa mucho tiempo en el teléfono, cuando sueña dibuja para no olvidar el sueño, la psicóloga escolar ha manifestado que le cuesta hacer amigos, en sexto grado se la pasaba solo, selectivo para comer, solo come limón, mango verde, no le gustan mucho las verduras, se muestra inocente, inmaduro para la edad que tiene. Le cuesta socializa, lo cual puede hacer con personas de confianza.

El paciente hace sus disfraces para la fecha de 31 de octubre.

Vive con madre, los padres se separaron cuando el paciente tenía 4 años, volviéndolo a ver 8 años después, con relación distante. No mide el peligro.

ANTECEDENTES MEDICOS PERSONALES

ENFERMEDAD MEDICA: Desgaste del fémur, sinovitis transitoria, alérgico. Utiliza aditamento (Gafas).

Quirúrgicos: NO.

Tóxicos: NO.

Hospitalizaciones: NO.

Inmunizaciones: Si.

Medicamentos: Loratadina. Meloxicam, inhaladores, montelukast.

ANTECEDENTES MEDICOS FAMILIARES

Discapacidad intelectual: No reporta

Alcoholismo: No reporta

Drogadicción. No reporta

Epilepsia: No reporta

TDAH: No reporta

Autismo: Primo en tercer grado.

CONDICIÓN DEL PACIENTE EN LA CONSULTA

Paciente con adecuada presentación personal, se muestra alerta, motivado, adecuada higiene postural, orientado auto y desorientado alopsiquicamente, lenguaje y pensamiento no fluido, bradilalia, bradipsiquia, problemas en aprendizaje, algunas fallas comprensivas, juicio y raciocinio adecuado, inteligencia aparentemente normal, no restricciones en la locomoción, se muestra colaborador.

PRIMERA PRUEBA APLICADA

Se realizo prueba NEUROPSICOLOGICA Escala de inteligencia de Wscheler para adultos, WAIS – cubos, búsqueda de símbolos, claves, dígitos, dígitos en orden directo, inverso y creciente, Semejanzas, comprensión, información, vocabulario, matrices, aritmética, rompecabezas visuales.

RANGO DE PERCENTILES DE PRUEBA DE INTELIGENCIA

Rango percentil	Clasificación
130	Muy superior
120 - 129	Superior
110 - 119	Promedio alto
90 - 109	Promedio
80 - 89	Promedio bajo
70 - 79	Inferior
55 - 69	Discapacidad leve
40 – 54	Discapacidad moderada



ÍNDICE	SUB-PRUEBA	PN	PE	DESCRIPCIÓN
Comprensión verbal (ICV)	Semejanzas (SE)	12	5	Muy Bajo
	Vocabulario (VB)	31	10	Promedio
	Información (IN)	14	12	Promedio
Razonamiento Perceptual (IRP)	Diseño con Cubos (DC)	49	12	Promedio
	Matrices (MT)	11	6	Medio Bajo
	Rompecabezas Visuales (RV)	15	10	Promedio
Memoria de trabajo (IMT)	Retención de dígitos (RD)	29	12	Promedio
	Aritmética (AR)	15	12	Promedio
Velocidad de Procesamiento (IVP)	Claves (CL)	58	8	Promedio
	Búsqueda de símbolos (BS)	34	11	Promedio

ÍNDICES PRIMARIOS	S. de PE	PCo	DESCRIPCIÓN
Comprensión verbal	27	92	Promedio
Razonamiento Perceptual	28	96	Promedio
Memoria de Trabajo	24	110	Medio Alto
V. de procesamiento	19	98	Promedio
Coefficiente intelectual	98	97	Promedio

La Capacidad Intelectual Total (CIT), es un indicador de la relación entre los cuatro índices en los cuales se encuentran agrupadas las 10 subpruebas. Para obtener el CI total se utilizan siete de la diez pruebas (Cubos, semejanzas, matrices, dígitos, claves, símbolos, vocabulario, información, balanzas, rompecabezas). El paciente obtuvo un CIT de **97**, lo que lo ubica en un rango dentro del promedio para su edad y nivel escolar.

Comprensión verbal

El valor obtenido en CV es de **92**, se clasifica con una capacidad general **promedio**, ubicándose dentro del promedio esperado con relación con su edad escolar y grupo etario. Lo cual representa la capacidad para utilizar la información previamente aprendida, la experiencia educativa informal y formal, así como repertorios lingüísticos, manejo de analogías y análisis de relación.

Razonamiento visoespacial o perceptivo

El valor obtenido en RP es de **96**, se clasifica con una capacidad general **promedio**, ubicándose dentro del promedio esperado con relación con su edad escolar y grupo etario. El índice de razonamiento perceptivo incluye el razonamiento espacial y la integración visomotora, procesos viso perceptuales y visos construccionales, así como razonamiento abstracto. De esta manera se identifican capacidades para analizar y sintetizar estímulos visuales, para categorizar, clasificar, dar juicios analógicos y razonamientos seriales dando cuenta de forma verbal.

Memoria de Trabajo

El valor obtenido en MT es de **110**, se clasifica con una capacidad general **promedio alta**, ubicándose un rango por encima del promedio esperado con relación con su edad escolar y grupo etario. El índice de la memoria de trabajo (MT) es una medida de la memoria a corto plazo reflejando la capacidad para retener temporalmente en la memoria cierta información, trabajar con ella y generar resultados, implicando razonamiento, concentración, control mental.

Velocidad de procesamiento

El valor obtenido en VP es de **98**, se clasifica con una capacidad general **promedio**, ubicándose dentro del promedio esperado con relación con su edad escolar y grupo etario. En esta prueba se mide la relación entre tiempo y tarea, capacidad de discriminación, de focalización de la atención y selección de estímulos visuales. Se encuentra capacidad para parear información simple y para reconocer visualmente información en un periodo de tiempo determinado.

SEGUNDA PRUEBA APLICADA

Protocoló neuropsicológico para valoración de las funciones mentales superiores: Neuropsi: Orientación, atención y concentración, memoria de codificación y decodificación, lenguaje, funciones ejecutivas conceptuales y motoras.

Funciones ejecutivas: Criterios DSM V y CIE 10 - Escala de AVD e Instrumentales) - Escala Global de deterior. (EDG).

NEUROPSI														
EVALUACIÓN NEUROPSICOLOGICA BREVE EN ESPAÑOL														
RANGO DE EDAD: 16 – 30 NIVEL DE ESCOLARIDAD: 10 - 24 AÑOS DE ESTUDIO														
NORMAL ALTO ☐				NORMAL ☐				MODERADO ☐				SEVERO ☐		
PUNTUACIÓN ESTANADARIZADA														
ORIENTACIÓN	3		2		1		0		-1		-2		-3	
TIEMPO							3						0-2	
							X							
LUGAR							2						0 - 1	
							X							
PERSONA							1						0	
							X							
Permite establecer el nivel de conciencia y estado general de activación. Mide la orientación alopsíquica y autopsíquica, si existe alteración en los dos procesos existe alteración global de la orientación.														
ATENCIÓN CONCENTRACIÓN	3		2		1		0		-1		-2		-3	
DIGITOS				6		5	4		3		2		0	
				X										
DETECCIÓN VISUAL						16	13-15	12	11	10	8.9		0-7	
							X							
20-3					5		3-4		2	1	0			
					X									
Evalúa la habilidad para enfocar y sostener la atención. Activación, concentración y atención selectiva – Evalúa la hemi-inatención espacial y sensorial. Dígitos evalúa la capacidad de memoria de trabajo.														

MEMORIA CODIFICACIÓN	3		2		1		0		-1		-2		-3	
PALABRAS					6		5		4		3		0-2	
						X								
FIGURA REY							12	11.5		11			0-10.5	
							X							
Evalúa la memoria a corto plazo de contenido auditivo verbal y visual. (Evalúa la capacidad de retención, almacenamiento y evocación) Evalúa efecto de primacía y recencia en la memoria inmediata de contenido auditivo verbal. La figura de Rey - Evalúa la organización perceptual y la memoria visual, rastreo visual, organización perceptual, praxias viso constructivas.														
MEMORIA EVOCACIÓN	3		2		1		0		-1		-2		-3	
ESPONTANEA						6	5		4			3	0-0.2	
												X		
POR CATEGORIAS						6		5		4		3	0-2	
										X				
RECONOCIMIENTO						6		5				4	0-3	
						X						X		
FIGURA DE REY						12	10.5-11.5	10	9.5	9	8-8.5		0-7.5	
						X								
Evalúa la memoria a largo plazo de contenido auditivo verbal y visual. (Evalúa la capacidad de retención, almacenamiento y evocación después de intervalo con interferencia). Brinda información sobre el funcionamiento neuropsicológico.														
LENGUAJE	3		2		1		0		-1		-2		-3	
DENOMINACIÓN							8						0-7	
							X							
REPETICIÓN							4						0-3	
							X							
COMPRENSIÓN							6						0-5	
							X							
FLUIDEZ VERBAL SEMANTICA				30-32	28-29	25-27	19-24	17-18	14-16	11-13	10		0-9	
							X							

FLUIDEZ VERBAL FONOLÓGICA		25	23-24	21-22	19-20	17-18	12-16	10-11	8-9	6-7	4-5		0-3	
							X							
Evalúa el procesamiento lingüístico como la fluidez, (Pone a prueba los mecanismos necesarios para el acceso al léxico, evocación y denominación), comprensión (seguimiento de instrucciones, evalúa la comprensión los verbos y las preposiciones incluidos en las instrucciones, sintaxis, evalúa la interpretación basado en los componentes de atención, memoria y lenguaje), repetición (Evalúa habilidades de pronunciación y articulación de diferentes fonemas producción del habla, denominación).														
LECTURA/ESCRITURA	3		2		1		0		-1		-2		-3	
LECTURA							3				2		0-1	
							X							
DICTADO							1						0	
							X							
COPIADO							1						0	
							X							
Lectura (Evalúa la eficiencia lectora alcanzada por la persona evaluada, evalúa conversión grafema - fonema, identificación adecuada de las palabras para la recuperación de su pronunciación) y escritura (evalúa los procesos de segmentación fonética y recuperación de los grafemas de cada de cada palabra y la destreza manual necesaria para la escritura).														
FUNCIONES EJECUTIVAS CONCEPTUALES Y MOTORAS	3		2		1		0		-1		-2		-3	
SEMEJANZAS							6	5			4		0-3	
							X							
SECUENCIACIÓN							1						0	
							X							
CALCULO						3		2				1	0	
												X		
MANO DERECHA						2				1			0	
													X	
MANO IZQUIERDA						2			1				0	
													X	
MOVIMIENTOS ALTERNOS							2						0-1	

													X	
REACCIONES OPUESTAS							2						0-1	
							X							
Evalúa la capacidad de planeación, secuenciación, organización de la información y la conducta. Evalúa la capacidad de anticipación, selección de una meta. Mide posibles alteraciones orbitofrontales, convexidad frontal y medial frontal.														
PUNTUACIONES NORMALIZADAS NEUROPSI														
Puntuaciones totales					Puntuación total normalizada					Clasificación				
Total atención y memoria					109					Normal				

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Resultados de evaluación:

ORIENTACIÓN: Adecuada orientación auto y alopsíquica.

ATENCIÓN: Presenta un desempeño adecuado en la atención focalizada, sostenida, selectiva (no distractivo, tendencia a la hipoprosexia). La atención focalizada le permite mantenerse en un estímulo relevante independientemente del tiempo, la atención sostenida le permite la capacidad de mantener el foco en una actividad o estímulo durante un tiempo determinado, la atención selectiva le permite establecer la capacidad de focalizar la mente en un estímulo o una tarea concreta, sin permitir que otros estímulos interrumpan lo que se está haciendo.

Presenta adecuada atención auditiva, adecuada búsqueda organizada de los estímulos, así como una correcta velocidad en la ejecución de tareas que se deben ejecutar en un tiempo específico en las tareas de inteligencia, sin embargo en las pruebas como figura de rey, respuestas de abstracción, información, vocabulario las respuestas estuvieron por debajo del promedio, lo cual puede penalizar el procesamiento rápido y la ejecución de tareas que requieran que se ejecuten en un tiempo específico.

MEMORIA: Presenta adecuada memoria ecoica e icónica, la memoria de trabajo presenta un desempeño por encima de lo esperado, un rango, facilitando el manejo de la información en línea y de forma simbólica, puede ser que por la baja flexibilidad pueda pensar en algunos momentos que tiene la verdad absoluta no permitiendo comprender las demás perspectivas.

El paciente presenta una adecuada capacidad de memoria inmediata, a corto plazo de contenido auditivo verbal, con alta capacidad

en procesos que requieren un tipo de memoria de contenido visual a corto y largo plazo.

Se observo dificultades en las evocaciones relacionadas con la memoria a largo plazo y aprendizaje significativo en tareas de contenido auditivo verbales que mejoran aunque por debajo del promedio con el uso de claves semánticas y fonológicas.

LENGUAJE: Presenta un desempeño adecuado en la fluidez verbal aunque se muestra tímido, inhibido, inocente, en ocasiones su lenguaje es disprosodico, (acento particular visto como mecánico o de caricatura), con fuga de ideas de baja intensidad (responde con otro tema que no esta relacionado a lo que se le pregunta).

Existe adecuado vocabulario, adecuada capacidad de información, fluidez semántica y fonológica aunque con bajas respuestas abstracción, lo cual puede dificultar el manejo de información verbal a pesar de tener un alto nivel en memoria de trabajo y visual, lo que significa que el paciente puede saber mucha información pero no logra expresarla en ocasiones de forma funcional, a lo que se suma un pensamiento rígido.

Lectura: Existe adecuada eficiencia lectora, lo que quiere decir que existe adecuada conversión grafema - fonema, con identificación adecuada de las palabras para la recuperación de su pronunciación.

No se observaron sustituciones como lexicalización, con adecuado uso de literales, no se observaron omisiones de la letra o inadecuado uso de segmento.

Escritura: Existe adecuado lenguaje escrito, con normales respuestas en los procesos de segmentación fonética y recuperación de los grafemas de cada palabra y la destreza manual necesaria para la escritura. No se observa macrografía, adecuada utilización de signos de puntuación, no existe confusión de consonantes, adecuada pinza trípode. No se observó temblor, rigidez o movimientos involuntarios.

PRAXIAS VISO CONSTRUCCIONALES: Se identifica nivel normal para la edad y escolaridad en lo que se refiere a la copia de modelos a través del sistema grafo motor, coordinación viso motora y proceso viso perceptuales. No se observa dificultad en el proceso para el manejo de proporciones, detalles de la imagen, integración de los elementos, exactitud, sin omisión de los elementos.

El paciente es capaz de desvestirse, vestirse por sí solo, abotonarse, mantener una adecuado equilibrio, adecuada locomoción pero bajo del peso corporal, con poca motivación por actividades relacionadas con el deporte o ejercicio, con mayor preferencia por las tecnologías.

Al paciente le cuesta ser espontaneo, imitar gestos convencionales, así como lo que dice con bajo acompañamiento de gestos motores.

GNOSIAS: No se observan alteraciones en el reconocimiento de la información previamente aprendida a través de nuestros sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto.

FUNCIONES EJECUTIVAS:

Descripción clínica) Cribado con adecuada autorregulación, no se observó problemas con la inhibición y control de su conducta, le cuesta hacer análisis de su comportamiento, le cuesta planificar y organizar su conducta hacia una meta, por momentos su pensamiento y lenguaje se ajusta al contexto, poca flexibilidad cognoscitiva), le cuesta la toma de decisiones, fallas en abstracción, calculo, desarrollo de ejecuciones motoras, aunque presenta adecuada memoria de trabajo y fluidez verbal.

Paciente con **CIT** de **97**, lo que lo ubica en un rango de acuerdo con el WAIS IV con **capacidad general intelectual promedia**, sin embargo, las bajas puntuaciones en abstracción, memoria a largo plazo de contenido verbal, calculo, fallas en funciones ejecutivas, pueden limitar el aprovechamiento y rendimiento académico en el aula escolar, toda vez que existirá bajo desarrollo en algunas áreas sobre todos las que impliquen un alto nivel de razonamiento complejo, flexibilidad, iniciativa, creación y manejo de la información verbal.

Se observa adecuado desarrollo de la capacidad cognoscitiva en la comprensión verbal 92 y habilidades visoespaciales de 96, lo cual establece un adecuado desarrollo del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, aunque se observe disprosodia, afecto plano, fuga de ideas, poca flexibilidad, fallas en abstracción que deben ser objeto de atención clínica.

La memoria de trabajo, 110, se encuentran dentro del rango promedio alto, facilitando el manejo de la información a corto, plazo, en línea, siendo un punto fuerte normativo en el desarrollo académico y habilidades intelectuales.

La velocidad de procesamiento, 98, se encuentran en el rango promedio, lo que puede establecer facilidad en las respuestas de forma rápida, efectiva y sin interferencia, punto fuerte normativo en el desarrollo académico y habilidades intelectuales

Perfil del paciente:

Según la aplicación de las pruebas y observación clínica se obtiene un perfil de paciente con un nivel de inteligencia promedio, con alto riesgo de tener síndrome asperger o autismo con apoyo de grado 1 (leve), con mayor desarrollo del componente verbal que manipulativo, que debe evaluarse con la aplicación de la prueba ADOS 2, la cual es la herramienta estándar para definir este tipo de nosologías.

El paciente presenta un desempeño general adecuado en comprensión verbal, pero con dificultad en abstracción o manejo de la

información verbal compleja, acompañada de disprosodia, fuga de ideas, razonamiento perceptivo, razonamiento fluido, media alta capacidad en memoria de trabajo, algunas dificultades en velocidad de procesamiento pese a tener una puntuación general adecuada, se debe hacer seguimiento al detallismo de mediana frecuencia, fuga de ideas de baja frecuencia, poca flexibilidad, afecto plano, disprosodia, desajustes corporales, inadecuada pinza trípode pero funcional, hiporeactividad – selectividad a comidas, molestia por ruidos elevados, conducta desadaptativa – le cuesta adaptarse a los cambios, pensamiento rígido, dificultades en la reciprocidad socioemocional, intereses restrictivo y particulares, dificultades en las relaciones sociales de su grupo etario, afecto plano, le cuesta hacer amigos, prefiere estar solo, tiene un estilo de comunicación que se desvía de los patrones normales, con un lenguaje formal, adornado, mecánico, desea ser sociable pero fracasa en el desarrollo de relaciones, afectación de la capacidad de memoria a largo plazo y aprendizaje, funciones ejecutivas, desarrollo motor complejo, lo cual puede afectar el desempeño personal, social, familiar y sobre todo escolar.

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

F845 SÍNDROME DE ASPERGER (Trastorno del espectro del autismo grado 1) – Estudio. (Necesidad de aplicación de escala ADOS – 2, para confirmar o descartar nosología.

CIT DE 97, CAPACIDAD GENERAL INTELECTUAL PROMEDIA.

PLAN DE TRATAMIENTO

Consulta control por neuropsicología tres meses.

Necesidad de aplicación de ADOS 2.

Rehabilitación neuropsicológica que debe realizar un neuropsicólogo@ 2 veces por semana durante dos meses para fortalecer la abstracción, funciones motoras, procesos de esfuerzo al logro, motivación, automotivación, metacognición, automonitoreo, funciones ejecutivas, abstracción, planificación, organización y seguimiento de secuencia, entrenamiento en técnicas de estudio, comprensión verbal, flexibilidad, entender diferentes puntos de vista.

Rehabilitación dos veces por semana durante 2 meses desde psicología clínica que permita abordar seguridad, confianza, desarrollar habilidades en la resolución de problemas, adopción de perspectiva, desarrollo de asertividad; habilidades de afrontamiento; entrenamiento en habilidades sociales.

Realizar adecuación y adaptación curricular: Implementación del plan Individual de apoyos y ajustes razonables (PIAR) [Subsección 3 Esquema de atención educativa - Artículo 2.3.3.5.2.3.5], por parte de la institución educativa, que permita favorecer el proceso de avance del - la niña(o) en sus aprendizajes escolares, y fomentar la motivación hacia los mismos. Lo anterior implica ajustar los logros y competencias al nivel del - la niña(o), estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo en el transcurso del grado escolar que curse y mecanismos que permitan potencializar los aprendizajes mediante diferentes estrategias de evaluación de contenidos y logros acordes a sus capacidades y no las del grupo exclusivamente.

Dar un trato digno.

Los docentes deberán ayudar al menor a lograr los siguientes aspectos.

Rutinas claras: Sigue una rutina diaria establecida, con instrucciones claras y pasos específicos para cada actividad, lo que ayuda a reducir la confusión y mejorar la atención.

Tiempos de descanso: Toma pequeños descansos entre tareas para recargar la atención. Puedes usar técnicas como la técnica Pomodoro (trabajar 25 minutos y descansar 5).

Tareas cortas y específicas: Divide las tareas grandes en partes más pequeñas y manejables, para que sea más fácil concentrarse en una cosa a la vez.

Uso de apoyos visuales: Utiliza agendas, listas de verificación, esquemas o dibujos para seguir instrucciones y mantenerse enfocado en lo que hay que hacer.

Minimizar distracciones: Busca un lugar tranquilo en el aula, si es posible, y reduce ruidos o estímulos que puedan distraer.

Técnicas de concentración: Practica ejercicios de respiración, mindfulness o atención plena para mejorar la capacidad de mantener la concentración.

Refuerzo positivo: Reconoce y celebra los esfuerzos y logros, por pequeños que sean, para motivar la atención y el interés en las tareas.

Comunicación con docentes: Mantén una comunicación abierta con los maestros para ajustar estrategias y recibir apoyo adicional cuando sea necesario.

Apoyo emocional: Fomenta la confianza y la paciencia, recordándole que mejorar la atención lleva tiempo y esfuerzo, y que está haciendo un buen trabajo.

Utilice un tono de voz cordial, siempre, mantenga la calma, evite que las conductas escalen, sáquela de situaciones que la alteran, coloque un compañero que ayude las habilidades sociales por modelado.

Enseñe a sus compañeros que la estudiante necesita menos ruido para concentrarse, edúquelos acerca de algunas dificultades que pueden afectar su desempeño, esto la ayudara a ella y los hará a sus compañeros mejores personas.

Apoye las clases desde lo motor y visual, será más fácil para aprender.

Contemple los días más desadaptativos, no se lo tome personal.

Respete su estilo y ritmo de aprendizaje.

Cree rutinas para cada día, visible donde pueda anticipar las actividades, agendas con fotos, pictogramas.

Apoye algunas clases con historietas, videos, cómics.

Explique la tarea por secuencia, paso a paso, apoyado en dibujos.

Elija un grupo de amigos que esté dispuesto a guiarle y a interactuar con él.

Haga del salón de clase un lugar donde el estudiante tenga expectativas y se encuentre motivado y valorado, dar los buenos días, preguntar siempre si ha comprendido, si necesita ayuda favorece un mayor desarrollo académico.

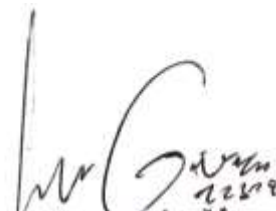
Tener en cuenta que existen dificultades en la comprensión verbal, algunas respuestas pueden carecer de consistencia, apoye las respuestas en videos o con retroalimentaciones, valga el esfuerzo que hace el estudiante de participar.

Reduzca el número de preguntas en los exámenes pues la velocidad de procesamiento está afectada, esto puede hacer que tarde más de lo habitual en responder sobre todo en las asignaturas donde no tiene un buen rendimiento.

No lo obligue a partir de determinadas actividades, anticipe antes, no es que el se quiera hacer o algo parecido es que existe una dificultad de flexibilidad que le impide ver las cosas como usted las puede comprender, no lo obligue sin dejar de persuadirlo a desarrollar ciertas tareas, pero en caso de no realizarlas no puede afectar la nota.

Permítale recuperar materias, repita exámenes si los pierde, en caso de seguir perdiéndolos, mande talleres, por favor sin discriminar o permitir matoneo.

Seleccione un grupo para que lo integre sin decir que hay riesgo de autismo, refiere que tiene dificultades de comunicación e interacción.



Jainer E. Guzmán Vega
Psicólogo - M.G Neuropsicología
T.P 123096

Firma U.S.B. - Medellín

Nombre del Profesional: Jainer Enrique Guzmán Vega

Especialidad: M.G Neuropsicología – Universidad de San Buenaventura de Medellín.

No. Tarjeta Profesional: 123096

PRASCA
CENTER